

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PACIENTE	Código: PRD-GD-01 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	--	--

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PACIENTE

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento general para la gestión documental de los expedientes de pacientes, garantizando el ciclo vital del documento (creación, organización, transferencia y disposición final) de acuerdo con los estándares legales y de habilitación.

2. ALCANCE

Aplica a todos los documentos clínicos y administrativos que conforman el expediente del paciente (consentimientos, historia clínica, pruebas psicotécnicas, remisiones) desde el primer contacto hasta su archivo inactivo.

3. RESPONSABLES

- Profesional en Psicología.
- Personal Administrativo (cuando aplique, bajo estrictos acuerdos de confidencialidad).

4. MARCO NORMATIVO

- Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos).
- Resolución 839 de 2017 (Gestión de Historias Clínicas).
- Resolución 3100 de 2019 (Estándar de Historia Clínica y Registros).

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

- 5.1. Generación y Recepción: Todo documento anexo al expediente (ej. consentimientos firmados, resultados de exámenes, oficios) debe ser recibido, fechado e integrado a la historia clínica del paciente de manera inmediata.
- 5.2. Foliación Continua: Para los expedientes físicos, todos los documentos deben ser numerados de forma consecutiva (foliación) en la esquina superior derecha, utilizando lápiz de mina negra, asegurando el orden cronológico.

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PACIENTE	Código: PRD-GD-01 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	--	--

- 5.3. Organización Interna del Expediente: El expediente físico o digital debe estar estructurado lógicamente: 1. Datos demográficos, 2. Consentimientos informados, 3. Evoluciones clínicas, 4. Pruebas o anexos externos.
- 5.4. Transferencias Documentales: Establecer las fases de archivo. Archivo de Gestión (pacientes activos, retención de 5 años) y Archivo Central (pacientes inactivos, retención adicional de 10 años).
- 5.5. Reconstrucción de Expedientes: En caso de pérdida, deterioro o fuerza mayor, se levantará un acta de pérdida y se iniciará un proceso de reconstrucción contactando al paciente y recuperando copias de seguridad (backups).

6. PUNTOS DE CONTROL PARA AUDITORÍA

- Evidencia de expedientes debidamente foliados y organizados.
- Protocolo documentado de reconstrucción de historias clínicas.
- Acuerdos de confidencialidad firmados por el personal administrativo.